

Mucoviscidose

glandes sécrètes + mucus

Dépistage néonatal: TIR (Tigheir & prout) = test Guthrie



Test génétique → Gène CFTR

Dépistage tardif: Test à la sueur (test en sel)

CFTR = Transporteur ion chlorure Cl^-

Cl^- et Na^+ à eau au niveau du mouvement → Hydratation mucus (pas SOL)



GEL = visqueux, piège les bactéries

SOL = liquides, permet le balayage des cellules

Si appétit aussi PCL = Liqueur Pécillieuse

⚠ CFTR ne définit pas seul la gravité de la maladie = lien N-glycane

SLC6A14 → évacue le mucus

Allèle CFTR + SLC6A14 plus grave!

Traitement → Symptomatique; échec des autres

Augmenter les mouvements H_2O → mucus

Solutions Hypertoniques

Amélioré = bloqueur récepteur canaux sodiques

Activité canaux Cl^- : ANO1; UTP & S

→ m'eff qu'un placebo

PP de CFTR

Classe 1: Précision codon STOP

• PCT-124 = Atalapha

Si finis en relation d'être de codon STOP

Classe 2: Trafic/Adressage déficient

• MPB: molécule chaperonne

• VX 809

Classe 3: Protéine non fonctionnelle

• VX 770: stimule l'activité de CFTR

• Orkambi: {Stimulant + chaperonne} → 4% amélioré

• Kaftrio: 3 molécules → 12% amélioré

↳ MAIS coût élevé + long processus d'exclusion

Corde Vieuse

CFTR déficient

↓ Transport ion Cl^-

↓ Na^+ à eau dans le plasma SOL

mucus anormal

sténose des mucus

Obstruction bronchique

bronchite d'infection polémique

production mucus

↑ inflammation

↑ infection bactérienne

MICI (maladies intestinales chroniques idiopathiques)

2 Principales MICI : Rectocolite Hémorragique (RCH)

Uniquement le colon ; commune toujours strictement → caecum

- Douleurs abdominales
- Diarrhées glaires-sanglantes

marqueurs élevés avec
logue de démodération

Genes : HLA
MUC 19

En commun
IL 23R / IL 12B

Maladies de Crohn

Tout le tube digestif (de l'anus à la bouche) ; lésions Segmentaires (= on saute)

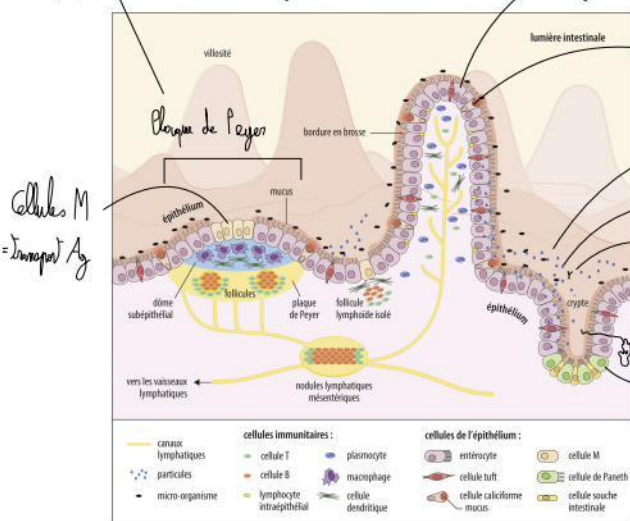
- Diarrhées Chroniques
- Douleurs abdominales
- Mal Absorption
- Abscès / Fistules / Sténoses

Anse intestinale épaissie
→ granulomes géogastocellulaires
SANS nécrose caséuse (= tubercule)

Genes : NOD2
ATG 16 L1 → Autophagosome

Intestin = 400 m²

Tissu lymphoïde intestinal = Épithélium folliculaire



Entérocyte (migrent depuis le fond de la crypte)

Cellules Caliciformes = \$ mucus + PAM
(peptides anti-microbiens
= combattre les bactéries à distance)

Mucus
PAM
IgA Sécrétées : élargissement de destruction pathogènes

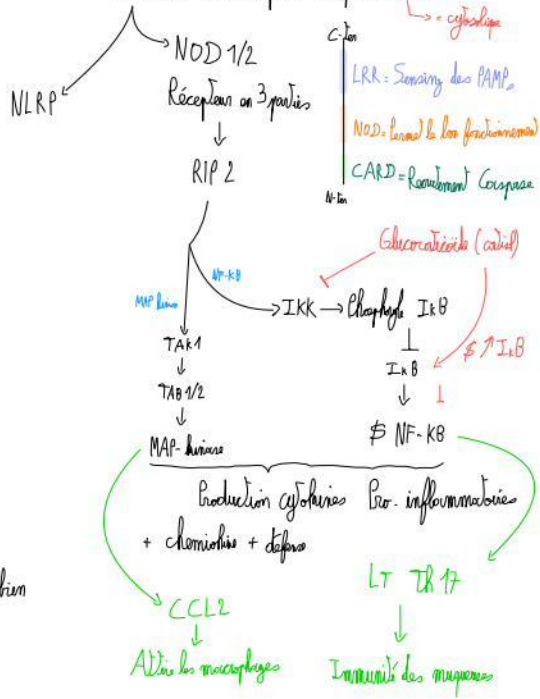
Macrophages + dendrites transépithéliales = Sensing microbien
Cellules de Paneth = défense via \$ PAM (E défenses)

PAMP (= pathogènes) → PRR
DAMP (= danger cellulaire)

TLR (Toll-Like Receptor) = récepteurs extracellulaires

RLR

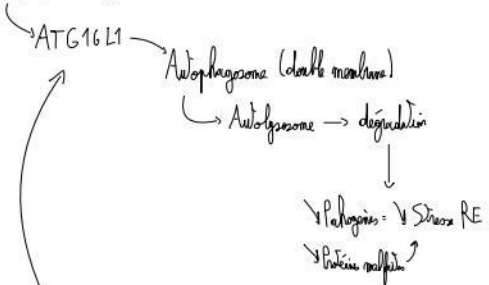
NLR (Nod-Like Receptor) = récepteurs intracellulaires



Donc : NOD2 = Réponse inflammatoire physiologique

Barrière de la cellule (membrane) TLR = Fournit (Barrière)

Autophagie = recyclage des composants intracellulaires (organelles endommagées / protéines agrégées / pathogènes intracellulaires) via les lysosomes



NOD2 → NF-κB = inflammation physiologique à bas bruit
↳ Défensive dans les PAM = PAM

MICI

↳ Elt génétiques NOD2 ; ATG 16L1 → Perte barrières protectrices → ↑ Pathogènes = Dysbiose

Ende cellule par cellule

Réaction Inflammatoire Chronique

TH1 TH17

LT_c

↳ Epithéliaux
↳ ↓ barrière ; ↓ cellules barrières
= ↑ Pathogènes
= Dysbiose
= Inflammation chronique (TH1/TH17)

↳ Macrophages
↳ Dysrégulation
↳ Réponse excessive → chronique

↳ Panneth
↳ Sensing ; ↓ Défenses
↳ Abscès dans les cryptes